ONEMA-POP-004 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA SAÚDE | POP-004

Avaliação de Suspeita de AVC no Atendimento Digital

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar reconhecimento de sinais sugestivos de acidente vascular cerebral (AVC) em contato remoto, ativação imediata

do serviço de emergência e comunicação estruturada. Não constitui diagnóstico, exame neurológico completo nem

tratamento remoto.

3. Competência, indicações e contraindicações

Aplicável ao enfermeiro em telenfermagem quando paciente, familiar ou cuidador relata alteração neurológica súbita. A

avaliação remota não deve retardar SAMU 192. Contraindicado manter observação remota como substituto de atendimento

emergencial, mesmo se os sintomas regredirem.

4. Materiais e responsabilidades

ONEMA fornece acesso seguro ao canal digital, formulário de triagem e Carteira Digital; paciente/cuidador fornece

localização, telefone de retorno e informações de horário/sintomas. Glicosímetro somente se já disponível e manuseado por

pessoa habilitada, sem retardar o resgate. Nenhum material invasivo é necessário.

5. Avaliação clínica e preparação

Confirmar identidade, localização exata, telefone e presença de acompanhante; identificar horário em que o paciente foi visto

pela última vez sem sintomas (último momento conhecido bem). Investigar início súbito de assimetria facial, fraqueza

unilateral, fala alterada, perda visual, desequilíbrio, cefaleia intensa incomum, rebaixamento de consciência ou convulsão.

6. Execução técnica numerada

1. Iniciar contato, confirmar local e telefone de retorno; perguntar se paciente está consciente e respirando normalmente.

2. Se houver sinal neurológico súbito, orientar acionamento imediato do SAMU 192; caso o acompanhante não consiga,

auxiliar na ativação conforme capacidade operacional. Não aguardar término de formulário.

3. Aplicar reconhecimento BE-FAST sem atrasar socorro: equilíbrio, olhos/visão, face, braço, fala e tempo. Perguntar sobre

outros déficits neurológicos súbitos.

4. Registrar hora exata de início ou último momento conhecido sem sintomas; distinguir hora do relato da hora real de início.

5. Verificar se há acompanhante; orientar que não deixe paciente sozinho, não ofereça alimentos, líquidos ou medicações

por via oral enquanto houver suspeita de alteração de deglutição/consciência.

6. Não orientar dirigir veículo próprio; aguardar serviço de emergência. Manter paciente em posição segura e confortável,

evitando mobilização desnecessária.

7. Se disponível, glicemia capilar pode ser aferida por pessoa apta, sem atrasar acionamento; comunicar resultado ao

resgate, sem concluir que exclui AVC.

8. Comunicar ao SAMU dados objetivos: endereço, sintomas, último momento conhecido bem, nível de consciência,

comorbidades, anticoagulantes e contato do acompanhante.

9. Permanecer no canal, quando viável, até confirmação de acionamento/chegada do resgate; escalar ao RT ocorrência de

falha de comunicação.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Qualquer suspeita de AVC = emergência, sem agendamento de visita eletiva. Se ausência de resposta, queda de consciência ou respiração anormal, instruir acompanhante a seguir orientações do regulador SAMU 192. Sintomas transitórios também exigem avaliação urgente. Não sugerir antiagregantes/anticoagulantes ou redução empírica da pressão.

8. Cuidados posteriores e orientação

Após transferência, orientar familiar a levar lista de medicamentos, horários e histórico; não prometer diagnóstico nem desfecho. Recontato ONEMA apenas para continuidade após estabilização e alta, sem substituir atendimento de urgência.

9. Registros Carteira Digital ONEMA

Registrar identificação e local, queixa e cronologia, último momento conhecido bem, sinais BE-FAST, informações fornecidas

por terceiros, orientações, horário de acionamento 192, confirmação do encaminhamento, intercorrências de contato, nome

do enfermeiro, data/hora e assinatura eletrônica.

10. Referências técnicas rastreáveis

Ver lista de fontes ao final; recomendações BE-FAST, acionamento imediato e glicemia sem atraso apoiadas nas fontes AHA/ASA e NHS.

FONTES CONSULTADAS E LINKS

American Heart Association, 2024. Focused Update on First Aid — Recognition of Stroke — https://professional.heart.org/-/m

edia/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/Highlights/2024-First-Aid/Highlights_2024FA_241118.pdf

American Stroke Association. Stroke Symptoms and Warning Signs —

https://www.stroke.org/en/about-stroke/stroke-symptoms

NHS. Symptoms of a stroke — https://www.nhs.uk/conditions/stroke/symptoms/